

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Transoesophageal Echocardiogram

معلومات الإقرار - نسخة المريض
مخطط صدى القلب عبر المريء

1. What is a transoesophageal echocardiogram?

This is a special type of heart ultrasound. Pictures of the heart are taken from inside the body. This procedure gives better quality pictures of the heart. A needle with a tube connected to it will be put in your arm. This is called an intravenous line or IV.

The equipment that takes the pictures is called the 'ultrasound probe'. The probe is put into the mouth and it passes down to the oesophagus. The doctor will see the back of the heart from this position.

You will have the following procedure:

The back of your throat will be sprayed with a local anaesthetic which will make it easier to swallow the ultrasound probe. The probe will be in place for about 15 minutes until the test is completed.

At the end of the test, the probe will be removed. Your throat will feel numb after the test. You will not be able to eat or drink anything for two hours after the test or until the numbness goes away.

2. My anaesthetic

This investigation will require an anaesthetic.

See **Local Anaesthetic and Sedation for Your Procedure information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

In recommending this procedure your doctor has balanced the benefits and risks of the procedure against the benefits and risks of not proceeding. Your doctor believes there is a net benefit to you going ahead. There are risks and complications with this investigation. They include but are not limited to the following:

Common risks and complications (more than 5%) include:

- Sore throat for a day or two afterwards.

Uncommon risks and complications (1 - 5%) include:

- Damage to your teeth or jaw due to the presence of instruments in your mouth.
- Tear in the oesophagus, which usually settles without treatment.

Rare risks and complications (less than 1%) include:

- Abnormal heartbeat that usually settles without treatment.
- Breathing problems. You may need medication to treat this.
- Oesophageal perforation. This may need surgery to repair.
- Death as a result of this procedure is extremely rare.

4. Before your procedure

- Do not eat a heavy meal, drink alcohol or smoke for 6 hours prior to your procedure.

1. ما هو مخطط صدى القلب عبر المريء؟

هو نوع خاص من الموجات فوق الصوتية للقلب. تؤخذ صور للقلب من داخل الجسم. يعطي هذا الإجراء صور أكثر جودة للقلب. يتم وضع إبرة في ذراعك موصلة بأنبوب ويسمى ذلك بالخط الوريدي. يسمى جهاز أخذ الصور من المعدة التي تلتقط الصور بـ "منظار الموجات فوق الصوتية". يتم وضع المنظار داخل الفم ويمر عبر المريء إلى الأسفل. يمكن للطبيب رؤية الجهة الخلفية للقلب من هذا الموقع.

ستخضع للإجراءات التالية:

سيتم تخدير الجهة الخلفية للحلق (الحنجرة) بمخدر موضعي على شكل بخاخ ، مما يعطيك سهولة في بلع المسبار. يمكث المسبار في هذا الموقع لـ 15 دقيقة إلى أن ينتهي الإجراء.

بنهاية الإجراء ، تتم إزالة المسبار. ستشعر بخدر في الحلق بعد نهاية هذا الإجراء ولن تستطيع الأكل أو الشرب لمدة ساعتين بعد الإجراء أو لحين زوال تخدر الحلق.

2. التخدير الذي أتلقيه

يتطلب الإجراء الخضوع للتخدير .

اقرأ تعليمات التخدير الموضعي والأدوية المسكنة المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها .

3. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟

لقد أوصى طبيبك بهذا الإجراء بعد قيامه بمقارنة وموازنة فوائد ومخاطر القيام بالإجراء مقابل فوائد ومخاطر عدم القيام به ، ويرى طبيبك أنك تحصل على فائدة أكثر بخضوعك لهذا الإجراء .

هناك مخاطر ومضاعفات مرتبطة بهذا الإجراء ، وهي تشمل ، ولكنها غير محصورة في :

مخاطر ومضاعفات شائعة (أكثر من 5%) وتشمل:

- ألم في الحلق ليوم أو يومين بعد الإجراء.

مخاطر ومضاعفات غير شائعة (1-5%) وتشمل:

- ضرر بصيب الأسنان أو الفك بسبب وجود معدة (جهاز) داخل فمك.
- تمزق في المريء عادة ما يشفى دون معالجة.

أخطار ومضاعفات نادرة الحدوث (أقل من 1%) وتشمل:

- ضربات قلب غير طبيعية عادة ما تختفي دون معالجة.
- مشاكل في التنفس . قد تستدعي إعطاء أدوية.
- ثقب في المريء قد يتطلب جراحة لإصلاحه.
- الوفاة بسبب هذا الإجراء نادرة جداً.

4. قبل الخضوع للإجراء

- لا تتناول وجبة كبيرة ولا تحتسي الكحول ولا تدخن لست (6) ساعات على الأقل قبل الإجراء.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Take your usual medication with a small sip of water, unless your doctor has advised otherwise. Bring a list of your medications to the hospital.
- Follow any additional instructions given to you by your doctor/hospital.

Notes to talk to my doctor about:

- تناول أدويةك المعتادة مع رشفات صغيرة من الماء ما لم ينصح طبيبك بغير ذلك. احضر معك قائمة بالأدوية التي تتناولها إلى المستشفى.
- اتبع أي تعليمات إضافية مقدمة لك من الطبيب أو المستشفى.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
